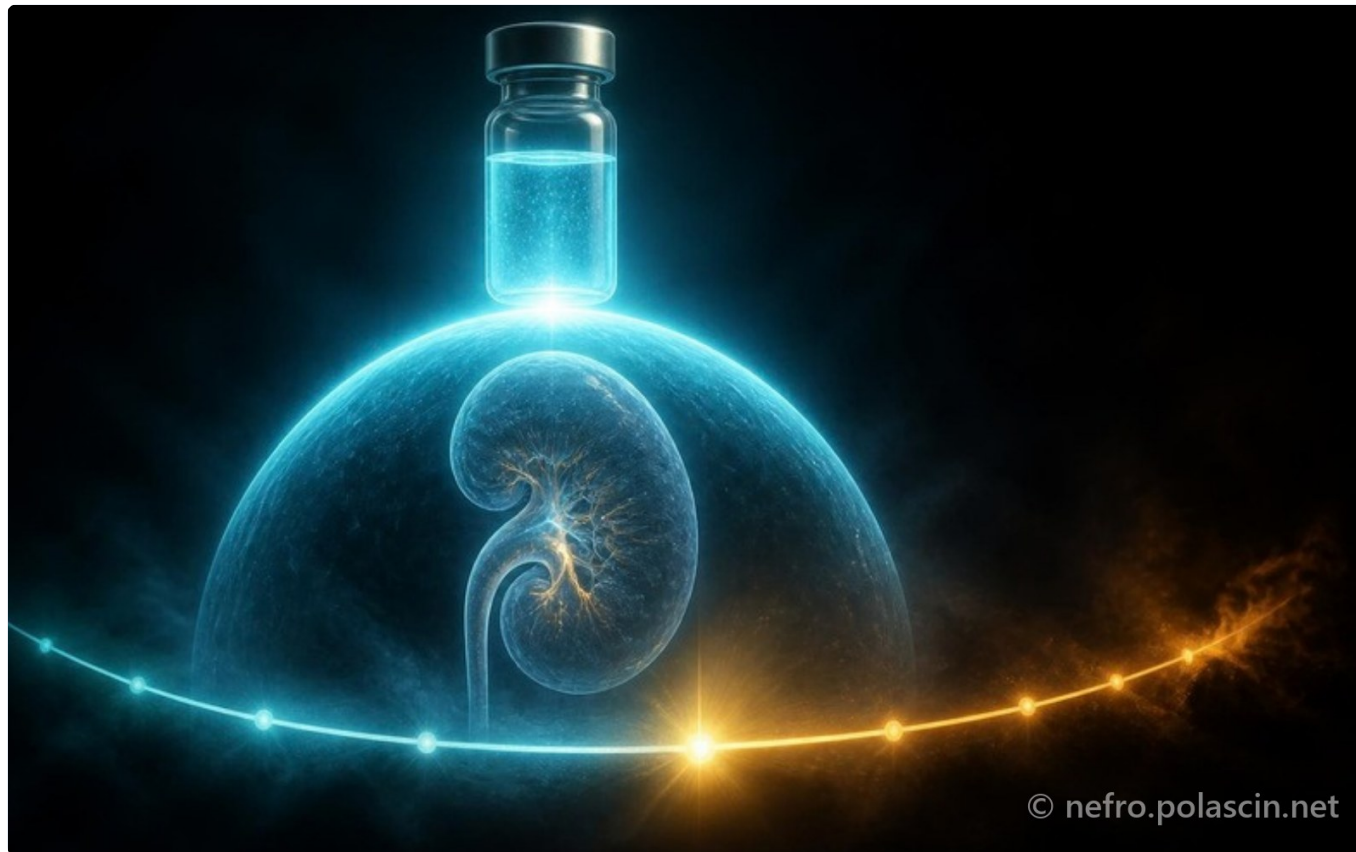


Očkovanie pri chronickej chorobe obličiek (CKD) a po transplantácii obličky: praktický prehľad vakcín a načasovania

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 10.10.2026



Ilustračná scéna. Ochrana je najsilnejšia, keď sa očkuje včas – po transplantácii je odpoveď imunitného systému slabšia.

Pacienti s chronickou chorobou obličiek a najmä po transplantácii obličky majú vyššie riziko závažných infekcií. Dôvodom je kombinácia zhoršenej imunitnej odpovede pri CKD a imunosupresie po transplantácii, ako aj častý kontakt so zdravotníckym prostredím (dialýza, ambulantné sledovanie). Očkovanie preto patrí medzi základné preventívne kroky.

Nižšie zhrňam odporúčania z prehľadu „Vaccinations to Prevent Infections in Adult Individuals With CKD and After Kidney Transplantation“ so zameraním na indikácie, načasovanie a typ vakcín.

Kľúčové princípy pri CKD a po transplantácii

V prehľade sa opakovane zdôrazňuje, že:

- o očkovaní sa rozhoduje podľa rizika (CKD štádium, vek, dialýza, typ imunitnej supresie),
- po transplantácii treba dodržať vhodný odstup očkovania od zákroku,
- pri transplantovaných pacientoch treba brať do úvahy špecifiká imunitnej odpovede a typ vakcíny (napr. pri chrípke sa uvádza zákaz živých vakcín).

Prehľad vakcín podľa infekcie

Influenza (chrípka)

- **Indikácia pri CKD aj po transplantácii:** pre všetkých pacientov **každoročne**.
- **Po transplantácii:** začať **4 týždne po transplantácii**, pričom sa uvádza „no live vaccine“ (t. j. nepoužívať živé vakcíny).

- **Po transplantácii podľa veku:**
 - **vek < 60 rokov:** štandardná jednorazová očkovacia schéma,
 - **vek ≥ 60 rokov:** *high-dose* (jednorazová schéma).

Pneumokok (Pneumococcus)

- **Indikácia pre CKD:** všetci pacienti **vo veku ≥ 19 rokov**.
- **Po transplantácii:** začať **6 mesiacov po transplantácii**.
- **Schéma podľa predchádzajúceho očkovania:**
 - ak pacient **ešte nebol očkovaný: 1× PCV**,
 - ak pacient **už dostal PPSV23: 1× PCV booster > 1 rok po PPSV23**.

RSV (respiračný syncytiálny vírus)

- **CKD:** všetci vo veku **≥ 75 rokov**, pri ktorých ide o **CKD 3+**.
- **Dialýza:** všetci vo veku **≥ 60 rokov**.
- **Po transplantácii:** všetci vo veku **≥ 60 rokov**, začať **6 mesiacov po transplantácii**.
- **Schéma:** jedna dávka, bez preferencie typu vakcíny.

SARS-CoV-2 (COVID-19)

- **CKD:** pre všetkých pacientov **každoročné revakcinácie**.
- **Po transplantácii:** rovnako **každoročná revakcinácia**, pri úvahe sa spomína **interval 6 mesiacov**.
- **Typ:** **jednodávková mRNA vakcína s aktuálnym variantom vírusu** (*most recent virus variant*).

Hepatitída B

- **CKD:** všetci pacienti so **CKD 3b-5**.
- **Po transplantácii:** v prehľade sa pri špecifikách uvádza „*No specific recommendation*“.
- **Schéma pri CKD:**
 - **3 až 4 injekcie** buď bežnej, alebo **dvojitej dávky** (podľa SPC príslušného prípravku),
 - **sérologické monitorovanie** a následné **preočkovanie (booster)** ako stratégia.

Herpes zoster (pásový opar)

- **Pri CKD podľa veku (hranice podľa jurisdikcie):**
 - **ACIP:** od **≥ 50 rokov**,
 - **RKI:** od **60 rokov**,
 - **NHS:** od **65 rokov**.
- **Pri imunokompromitovaných:** pacienti **≥ 19 rokov** s **terapeutickou imunosupresiou**.
- **Po transplantácii:** v prehľade je uvedené, že očkovanie sa týka **všetkých vo veku ≥ 19 rokov** (s výnimkou režimu RKI, kde je hranica **≥ 50 rokov**).
- **Schéma:** **2 dávky rekombinantnej vakcíny** podané **2 až 6 mesiacov** od seba.

Meningokok

- **CKD:** len pri **špecifických rizikách**, napr.:
 - asplénia,
 - inhibícia komplementu,
 - cestovanie do endemických oblastí.
- **Po transplantácii:** rovnaký princíp špecifického rizika.
- **Typ vakcíny v texte:** **MenB alebo MenACWY** podľa epidemiologickej situácie.
- **Schéma:** jedna dávka; treba **vyhodnotiť potrebu dodatočnej antibiotickej profylaxie**.

HPV (ľudský papilomavírus)

- **CKD:** v prehľade sa uvádza pre **deti 9–14 rokov**, „catch-up“ až do **26 rokov**.
- **Schéma:** rozšírená očkovacia schéma = **3 injekcie** v mesiacoch **0, 2, 6**.

Tetanus, diftéria, pertusis (Tdap/Td)

- **Indikácia:** všetci pacienti **každých 5 až 10 rokov** (rovnako uvedené pre CKD aj po transplantácii).
- **Schéma:** **jednorazová kombinovaná vakcína**.

Praktické zhrnutie pre nefrologickú ambulanciu

Pre prax je najcennejšie, že prehľad dáva jasný časový rámec pre dospelých s CKD a pre načasovanie po transplantácii: chrípka po transplantácii od 4 týždňov, pneumokok od 6 mesiacov, RSV od 6 mesiacov, a pri vybraných vakcínach schémy dávok s explicitnými časovými intervalmi.

Ambulantná pomôcka: očkovanie dospelých s CKD a po transplantácii

Použite ako rýchlu kontrolu v ambulancii. Konkrétny prípravok, dávku a dostupnosť vždy overte podľa miestnych odporúčaní a údajov o prípravku.

1) Dospelý s CKD (chronická choroba obličiek)

Infekcia	Kedy je indikované	Schéma podľa prehľadu
Influenza	všetci, každoročne	1 × ročne
Pneumokok	vek ≥ 19 rokov	podľa predchádzajúceho očkovania: buď 1 × PCV (ak nikdy), alebo 1 × PCV booster > 1 rok po PPSV23
RSV	vek ≥ 75 rokov, pri CKD 3+	1 dávka
SARS-CoV-2 (COVID-19)	všetci, každoročne	1 × ročne , podľa aktuálneho variantu
Hepatitída B	CKD 3b-5	3-4 injekcie (bežná alebo dvojitá dávka podľa konkrétnej vakcíny), so sérologickým monitorovaním a boosterom
Herpes zoster (pásový opar)	vekové hranice podľa jurisdikcie v prehľade (ACIP ≥ 50, RKI ≥ 60, NHS ≥ 65)	2 × rekombinantná vakcína, 2-6 mesiacov od seba
Meningokok	len pri špecifických rizikách (napr. asplénia, inhibícia komplementu, cestovanie)	podľa rizika ; v prehľade MenB alebo MenACWY , hodnotiť aj potrebu antibiotickej profylaxie
HPV	v prehľade 9–14 rokov a catch-up do 26 rokov	3 injekcie (mesiace 0, 2, 6)
Tetanus/diftéria/pertusis (Tdap/Td)	všetci, každých 5–10 rokov	1 × kombinovaná vakcína

2) Pacient po transplantácii obličky

Infekcia	Kedy začať po transplantácii	Schéma podľa prehľadu
Influenza	od 4 týždňov	každoročne; nie živá vakcína ; vek < 60 štandardná, vek ≥ 60 high-dose
Pneumokok	od 6 mesiacov	podľa histórie: 1 × PCV ak nikdy, alebo 1 × PCV booster > 1 rok po PPSV23
RSV	od 6 mesiacov ; vek ≥ 60	1 dávka (typ vakcíny v prehľade bez preferencie)

Infekcia	Kedy začať po transplantácii	Schéma podľa prehľadu
SARS-CoV-2	v prehľade ako každoročná revakcinácia	1x ročne, mRNA, most recent virus variant ; pri úvahe sa spomína interval ~6 mesiacov
Hepatitída B	po transplantácii: v prehľade bez špecifického odporúčania	sledujte podľa predošlej imunity a lokálnych protokolov
Herpes zoster	v prehľade plošne podľa veku	všetci ≥ 19 rokov (okrem výnimky pri RKI v prehľade); 2 dávky s intervalom 2-6 mesiacov
Meningokok	len pri špecifických rizikách	MenB alebo MenACWY podľa situácie; zhodnotiť antibiotickú profylaxiu
Tdap/Td	bez špecifického odkladu v prehľade	1x každých 5-10 rokov

Rýchly postup v ambulancii (1 minúta)

1. **Zistiť diagnózu a režim:** CKD (štádium) alebo transplantácia (imunosupresia).
2. **Vybrať skupinu:** tabuľka pre CKD alebo pre transplantovaných.
3. **Skontrolovať históriu očkovania** (najmä pneumokok, hepatitída B, zoster).
4. **Doplniť, čo chýba** podľa časových odkladov po transplantácii (najmä chrípka 4 týždne, pneumokok/RSV 6 mesiacov).

Zdroj: *American Journal of Kidney Diseases (AJKD): „Vaccinations to Prevent Infections in Adult Individuals With CKD and After Kidney Transplantation: A Review“.* [Link na zdroj](#).

Zdroj: <https://nefro.polasci.net/article.php?slug=ockovanie-ckd-transplantacia-oblicky-vakciny-nacasovanie> · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.